

受试者口服硝苯吡啶20mg,收缩压低于110mmHg者服用10mg。均在早上测定其服药前和服药后2小时的血压、心率、动脉血气、呼吸道阻力、用力肺活量和1分钟用力呼气容积。结果服药后,正常组和病人组均显示血压下降、心率增快($P < 0.01$)。呼吸道阻力、用力肺活量和1分钟用力呼气容积,正常服药前后均无显著差异,而病人组服药后均有显著改变,用力肺活量平均增加150ml ($P < 0.01$),1分钟用力呼气容积平均增加140ml ($P < 0.05$),而呼吸道阻力显著下降($P < 0.01$)。血气,正常组无改变,病人组也未示确定性改变。而肺气肿组和并发症组动脉血氧分压、动脉血二氧化碳分压均有显著降低,肺泡气—动脉血氧分压差均有显著增加。

讨论,平滑肌收缩和肥大细胞释放组织胺均依赖于钙,钙通道阻滞剂硝苯吡啶可抑制血管、子宫、泌尿道、食道、气管和支气管的平滑肌收缩,由于该药对支气管平滑肌的直接作用和抑制支气管周围肥大细胞释放组织胺,就能缓解支气管收缩。

该药不降低心排血量,受试者的肺血液灌注量可随心率的增加而增加,而肺气肿患者肺血流灌注增加而肺组织与血液接触时间减少,以致组织供氧不足。该药可引起分流的血管扩张和低氧的血管收缩,全肺内低通气血流比率会更明显。可使一侧或双侧肺泡—动脉血氧分压差增加。硝苯吡啶可扩张支气管,适用于慢性阻塞性肺病患者,对并发心血管病患者也有效。

〔摘自Drug Res 1985, 35(1):518(英文)〕

(李强译 甘代璞校)

调剂室落下尘的组成

调配散药时产生的尘埃叫药尘,医院中约有17%的药剂人员有过敏症状,药尘也是污染药品的原因之一。

作者以散剂调剂药尘为对象,用显微镜观察和薄层析法进行研究,以铜箔采集。一周内落下尘,重量平均为 $6.5\text{mg}/\text{cm}^2$ 相当于每小时 $14\text{mg}/\text{m}^2$,以计算器采集落下尘用显微镜观察。 $5\sim 20\mu\text{m}$ 的粒子占药尘量52%,其中卵圆形粒子占40%,显微镜下,与散剂的粒子比较,典型的卵形粒子与淀粉

酶、乳酶生、胰酶等微粒很相似,提示赋形剂药品及消化剂大量地存在于药尘中。

用薄层色谱法分析了调剂量较多的抗病药,其乙醇溶出量估计在药尘总重量的20%以下。从醇溶性成份二次展开的色谱图知,药尘量若为5mg即可显现斑点被检出。

药尘粒子比普通的室内粉尘大,浮游尘粒经在 $1\sim 5\mu\text{m}$ 之间,操作高峰时 $2\mu\text{m}$ 以上浮游尘增多。根据皮肤反应检查和通信调查,认为药剂人员过敏的药多是消化剂,且过敏率与药尘量有关。试样不是从天平或乳钵直接洒落的,而是曾一度飞散又落下的药尘,故有吸入或与皮肤、粘膜接触的机会,过敏症状多种。

使用色谱分析,在药尘中可检出调剂量多的呈强紫外吸收或具有荧光特性的药品,如有5mg药尘,即可定性。

以预防尘肺为主的劳动环境管理,历来只重视 $5\mu\text{m}$ 以下粉尘的浓度。最近日本产业卫生会就粉尘的允许浓度,建议用粒径在 $7\mu\text{m}$ 以下的吸入性粉尘的浓度和含有 $7\mu\text{m}$ 以上粒子的总粉尘浓度分别表示。

〔摘自药剂学 第44卷 1984 (日文)〕

左桂珍摘 马福民校)

狄戈辛和奎尼丁及安体舒通的药物相互作用

心功能不全和心律不齐患者,往往地戈辛、奎尼丁及安体舒通三种药物测定三种药物的相互作用表明,地戈辛的血药浓度,因与奎尼丁及安体舒通并用而上升,强度顺序为:三者并用、地戈辛与奎尼丁并用、地戈辛与安体舒通并用。地戈辛的全身清除率与安体舒通并用时减少31%,与奎尼丁并用时减少45%,三者并用时减少60%。肌酐清除率没有变化,对肾功能没有影响,分布容量也没有变化。作者认为特别是三药并用地高辛的血药浓度可上升150%,因此,其服用量有必要大幅度减少。

〔《药局》36(2):140, 1985,〕

日文罗顺德摘 王嘉陵校)

更正:本刊1986年第3期封四“四氮唑核苷”应为“三氮唑核苷”。

86年第六期封二、电号应为“32660, 32678, 32689”。